

## 经皮控释可乐宁贴剂单独和 联合利尿药治疗高血压的临床实验

作者选择的101例轻~中度原发性高血压病人(坐位舒张压91~105mmHg),在为期3个月的公开研究中,应用经皮控释可乐宁贴膏1~3块,每块3.5cm<sup>2</sup>(释放速度大约为每天0.1mg)。54例(64%)在整个治疗期间达到稳定的血压下降(舒张压减少 $\geq 10$ mmHg或降至90mmHg以下)。经皮可乐宁减少的血浆肾素活性和尿醛固酮排泄程度近似于已报告的口服可乐宁,治疗期间病人的肾功能或血清电解质浓度无影响。无1例因副作用需要停药者。

另一研究表明,接受双氢克尿塞和口服可乐宁的16例高血压病人,在维持2周的

稳定剂量后,可乐宁改为经皮贴膏。经皮用药期间的血浆可乐宁浓度近似于口服治疗时的谷浓度。还有两个研究也证明经皮和口服可乐宁联合双氢克尿塞有相等的疗效。其中一个研究指出,口服药物的峰、谷浓度引起的血压变化可被经皮吸收的稳定血药浓度限制到最小。

因此,经皮控释系统的可乐定制剂能产生较低且恒定的治疗血浆药物浓度,具有安全有效的临床价值。

(Am Heart J 108:231, 1984.)

(英文) 杨俊何摘 荣兴茂校)

## 呋喃硝胺的药物相互作用

呋喃硝胺(雷尼替丁, Ranitidine)口服吸收快,经肝脏首过代谢,主要以原型从肾脏排泄,肝、肾功能不良时其 $t_{1/2}$ 显著延长。与其它药物合用时可能发生药物相互作用概述如下:

### 一、影响药物的肝脏代谢

呋喃硝胺对肝脏药物代谢酶的抑制比甲氰咪胍弱得多。已知与甲氰咪胍有相互作用的药物,如心得安、利多卡因、苯妥因和安定,和呋喃硝胺合用时,没有明显的相互作用。因此,应用这些药物的病人需用H<sub>2</sub>-受体拮抗剂时,选用呋喃硝胺较合适。

呋喃硝胺抑制细胞色素P-450,可使华法令,美多心安、硝苯吡啶,茶碱和芬太尼的消除减慢。呋喃硝胺和华法令合用时,凝血酶原时间显著延长;和茶碱制剂合用时,茶

碱血浓度升高,甚至达到中毒水平,因此,临床上应警惕药物相互作用引起的毒性反应。另外,小鼠中研究证明高剂量(120mg/kg)呋喃硝胺使乙醇消除降低19%。

### 二、影响药物的吸收

呋喃硝胺使苯二氮草衍生物 Midazolam 的吸收显著增加,血浓度升高,产生较强的催眠作用,可能与呋喃硝胺抑制肝代谢酶活性有关。呋喃硝胺可显著减少钴胺的吸收,长期使用呋喃硝胺治疗的病人有钴胺缺乏的危险。

### 三、影响药物的肾脏排泄:

呋喃硝胺和普鲁卡因酰胺竞争共同的肾小管排泄部位,使后者AUC在27.7增加到31.5ng/ml·h,肾清除率从379减少到309ml/

(下转第48页)

药枕是祖国传统保健用品,在明代“本草纲目”及清代“医部全录”等名著中均有记载。为继承祖国医药遗产,上海中医学院剂型研究室与余杭县闲林综合厂在古方“神枕”的基础上,结合现代临床和药理知识研制了“延年药枕”。

上海中医学院剂型研究室主任徐莲英在会上介绍了“延年药枕”的研制过程,老年病研究室主治医师林水淼介绍了二十余例“延年药枕”的临床疗效观察小结。与会代表也对“药枕”的效果进行了广泛交流与讨论。

上海中医学院裘沛然教授等七位专家、教授组成的评审委员会,经过充分评议后一致认为:从中医“风为百病之长”的理论出发,选用具有祛风宣窍、调和营卫、活血通络、祛邪防病等功能的药物制成药枕,从现代药理分析,有预防感冒,镇静镇痛,扩张血管等作用,并且使用方便,有益健康,无明显副反应,是一种值得推广使用的保健用品。建议研制单位不断听取用户反映,积极提高产品质量和生产能力,更好地为人民健康事业服务。

(郑绥成)

## 嘉兴市分会举行年会

中国药学会浙江省嘉兴市分会于一九八五年十二月十五日至十六日在嘉兴市召开成立后首届年会。到会代表六十多人,会议有市科协 and 市卫生局领导出席并讲了话。由省药学会理事胡景华和张松石两同志传达了“全国工业药剂会议”及“中国药学会理事会和省理事会议”精神。大会交流论文五篇,并总结了八五年学会工作,讨论八六年工作。会后全体代表参观了南湖制药厂。

(孙树春)

## 《中成药研究》

### 文摘汇编征订启事

本文摘汇编为检索性工具书,系统介绍

1978~1982年《中成药研究》杂志新刊登的中成药制剂工艺、质量分析、炮制、药理、临床应用、生产设备、古方研究、知识讲座、小经验等文摘1000多条。旨为从事医药生产、科研、教学、药房、医务、情报等医药学工作者服务。每本定价6元(包括邮资)、现《文摘》才出版,欢迎订阅。

《中成药研究》编辑部地址:上海人民路324号开户银行及账号:上海人行黄办延东分理处3489662

(卢 陶)

## “中药药理与临床”在渝创刊

由中国中药药理学会和四川省中药研究所主办的《中药药理与临床》杂志最近在重庆创刊。这个刊物主要报道全国中药药理研究动态及科研成果,交流我国中药药理学术经验,开展学术争鸣,以促进我国中药药理学的发展。这个刊物现为季刊,编辑部设在重庆的四川省中药研究所内。

(上接第40页)

分。呋喃硝胺和N乙酰普鲁卡因酰胺合用也产生类似的相互作用。由于普鲁卡因酰胺和N-乙酰普鲁卡因酰胺的治疗指数小,与呋喃硝胺合用时应注意调整用量。

### 四、其它药物对呋喃硝胺吸收的影响

合并使用铝镁合剂(Mylanta II)时,呋喃硝胺的生物利用度减少33%;合用普鲁本率使呋喃硝胺AUC从2423ng/ml·h增加到2906ng/ml·h,这和甲氧咪胍所引起的相互作用却好相反。呋喃硝胺和Pirenzepine合用时抑制胃酸分泌的作用比两药分别应用时强。这种药效学的相互作用可能与呋喃硝胺抑制胆碱酯酶的活性有关。

[Clinical Pharmacokinetics 9:

493~510, 1984 (英文)

冯友根 摘 凌树森 校]